

CARDIOLOGIE



Hypertension Artérielle

Année 2025-2026

ITEM 224

PLAN DU COURS

I Définition et épidémiologie

II Diagnostic et bilan initial

III Prise en charge thérapeutique

LÉGENDE

★ Déjà tombé aux ECN

◆ Notion à haut rendement

⚠ Piège classique

I

Définition et épidémiologie

I

A. Définitions et seuils

★ Définition de l'HTA

- HTA : PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg au cabinet
- diagnostic confirmé sur deux consultations
- automesure : seuil abaissé à ≥ 135/85 mmHg

◆ Grades de sévérité

Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Grade 1	140-159	90-99
Grade 2	160-179	100-109
Grade 3	≥ 180	≥ 110

Démarche diagnostique de l'HTA

PA élevée au cabinet

Confirmation par MAPA

Bilan + traitement

Figure 1 — Étapes de la démarche diagnostique devant une pression artérielle élevée.

PIÈGE

Ne pas confondre l'HTA **blouse blanche** (PA élevée au cabinet uniquement) et l'HTA **masquée** (PA normale au cabinet, élevée en ambulatoire) : le pronostic diffère.

I | Définition et épidémiologie

I	B. Épidémiologie
Prévalence	- environ 30 % de la population adulte - augmente avec l'âge - premier motif de consultation en médecine générale
◆ Facteurs de risque	Non modifiables : âge, sexe masculin, hérédité Modifiables : surpoids, sédentarité, sel, alcool, tabac
À RETENIR L'HTA est un facteur de risque cardiovasculaire majeur : AVC, insuffisance cardiaque, coronaropathie, néphropathie.	

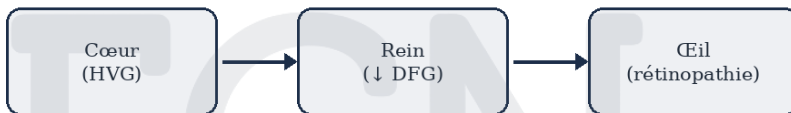
II | Diagnostic et bilan initial

II	A. Mesure de la pression artérielle
Conditions de mesure	- patient au repos depuis 5 minutes, assis - brassard adapté à la circonférence du bras - mesure aux deux bras lors du bilan initial
★ MAPA	- mesure ambulatoire de la PA sur 24 h - examen de référence pour confirmer le diagnostic - dépiste l'HTA masquée

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Automesure — **règle des 3** : 3 mesures matin et soir, 3 jours de suite.

II | Diagnostic et bilan initial

II	B. Bilan de retentissement
◆ Organes cibles	• Cœur : ECG, hypertrophie ventriculaire gauche • Rein : créatininémie, DFG, protéinurie • Œil : rétinopathie hypertensive si HTA sévère
Bilan biologique	• kaliémie, glycémie à jeun • bilan lipidique, créatininémie Retentissement sur les organes cibles  <pre> graph LR A[Cœur (HVG)] --> B[Rein (↓ DFG)] B --> C[Œil (rétinopathie)] </pre> Figure 2 — Principaux organes cibles atteints par l'hypertension artérielle.
PIÈGE ⚠ Rechercher une HTA secondaire si HTA résistante, sujet jeune ou signes d'orientation.	

III | Prise en charge thérapeutique

III	A. Mesures non médicamenteuses
Règles hygiéno-diététiques	• réduction des apports en sel (< 6 g/j) • perte de poids en cas de surpoids • activité physique régulière (30 min/j) • limitation de l'alcool, arrêt du tabac

III | Prise en charge thérapeutique

III

B. Traitement médicamenteux

★ Classes de 1re intention

Classe	Exemple	Indication
IEC	Ramipril	Diabète, IC
ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC
I. calcique	Amlodipine	Sujet âgé
Diurétique	HCTZ	Sujet âgé

◆ Stratégie

- **bithérapie d'emblée** souvent recommandée
- privilégier les **associations fixes**
- objectif : **< 140/90 mmHg**, voire **< 130/80 mmHg**

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Les 5 classes — moyen mnémotechnique « **A-B-C-D** » : **A**RA II / IEC, **B**êtabloquants, **C**alciques, **D**iurétiques.

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur	Précision
Seuil HTA au cabinet	140/90 mmHg	sur 2 consultations
Seuil en automesure	135/85 mmHg	règle des 3
Apports en sel conseillés	< 6 g/j	mesure hygiéno-diététique
Objectif tensionnel	< 140/90 mmHg	voire < 130/80 si toléré
Prévalence de l'HTA	≈ 30 %	population adulte

Grades de sévérité de l'HTA

Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Grade 1	140-159	90-99
Grade 2	160-179	100-109
Grade 3	≥ 180	≥ 110

Classes thérapeutiques de première intention

Classe	Exemple	Indication préférentielle
IEC	Ramipril	Diabète, insuffisance cardiaque
ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC (toux)
Inhibiteur calcique	Amlodipine	Sujet âgé
Diurétique thiazidique	HCTZ	Sujet âgé
Bêtabloquant	Bisoprolol	Coronaropathie associée

RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Hypertension Artérielle

Définition : PA $\geq$ 140/90 mmHg au cabinet (135/85 en automesure), confirmée sur 2 consultations.

Diagnostic : MAPA = examen de référence ; rechercher HTA blouse blanche et HTA masquée.

Bilan : organes cibles (cœur, rein, œil) + bilan biologique minimal ; évoquer une HTA secondaire si résistance ou sujet jeune.

Traitement : RHD systématiques + 5 classes (IEC, ARA II, calciques, diurétiques, bêtabloquants) ; bithérapie d'emblée fréquente ; objectif < 140/90 mmHg.

À retenir absolument

- L'**HTA** est définie par une PA $\geq$ **140/90 mmHg** au cabinet, confirmée sur des mesures répétées.
- La **MAPA** et l'**automesure** confirment le diagnostic et dépistent l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée.
- Le bilan initial recherche une **atteinte des organes cibles** et une **HTA secondaire**.
- Les **règles hygiéno-diététiques** sont la base du traitement.
- Cinq classes de 1^{re} intention ; la **bithérapie** est souvent d'emblée.
- Objectif : **< 140/90 mmHg**, idéalement **< 130/80 mmHg** si toléré.



MAJOR ECN · 2025-2026